PROEX: PROGRAMA DE APRENDIZAGEM SAÚDE E SOCIEDADE V · AULA 5

Medidas de associação e efeito

Da tabela de exposição e desfecho ao tamanho do benefício e do dano de uma intervenção.

F

Dr. Filipe Tomasi Keppen Sequeira de Almeida

Cirurgião cardiovascular · 19 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

0,5
metade do risco do grupo de comparação

10
pontos percentuais: de 20% para 10%

10
pessoas tratadas para evitar um infarto no exemplo

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	Da pergunta à tabela	3
02	Risco absoluto: dentro de cada grupo	5
03	Risco relativo: comparar e interpretar	5
04	Redução relativa e absoluta do risco	7
05	Quantos tratar? Benefício e dano	9
06	Odds e razão de chances	11
07	O essencial da aula	13

Conceitos, cálculos resolvidos e armadilhas de interpretação. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** pegadinha e erro comum
- **Roxo** complemento fora da aula
- **Em palavras simples** a ideia de cada capítulo
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** ponto enfatizado na aula
- **Você está aqui** sua posição na trilha

SOBRE O PROFESSOR · DR. FILIPE ALMEIDA

ESPECIALIDADE	Cirurgia cardiovascular.
FORMAÇÃO	Medicina pelo Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, entre 2015 e 2020, e Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Residência em cirurgia cardiovascular na Santa Casa de Londrina, entre 2021 e 2026. Mestrado em Gestão, Tecnologia e Inovação em Urgência e Emergência pela Universidade Estadual de Maringá.
ATUAÇÃO	Professor do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, em Cascavel. Atua no Instituto de Cirurgia Cardiovascular do Oeste do Paraná / Instituto Rui Almeida.
SOCIEDADE	Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.

00 Recados da disciplina

COMO SE PREPARAR PARA A PROVA

Não será permitido usar calculadora. Os números das contas serão simples; é necessário dominar a montagem da tabela e a sequência do raciocínio.

> “Você vai fazer prova de residência, vai cair isso aqui, você tem que saber fazer.”
>
> DR. FILIPE ALMEIDA, SOBRE OS CÁLCULOS DE RISCO

TRILHA DA AULA

01	02	03	04	05	06	07
Definir o desfecho	Montar a tabela	Calcular o risco	Comparar grupos	Medir a redução	Benefício e dano	Razão de chances

01 Da pergunta à tabela

Desfecho e tabela | Risco do grupo | Comparação | Redução | Benefício e dano | Chances

Primeiro separe quem recebeu a intervenção e quem faz parte do grupo de comparação. Depois conte quem apresentou o evento em cada grupo. Uma tabela bem montada organiza todas as contas seguintes.

Duas tabelas com finalidades diferentes PROVA

O que comparar	Tabela de diagnóstico	Tabela de exposição e desfecho
Pergunta	O teste identifica corretamente a doença?	O evento é mais ou menos frequente em determinado grupo?
Organização	Resultado do teste e presença real da doença.	Exposição ou intervenção nas linhas; presença do desfecho nas colunas.
Medidas	Sensibilidade, especificidade e valores preditivos.	Riscos, reduções, número necessário para tratar e razão de chances.

As duas têm duas linhas e duas colunas, mas respondem a perguntas diferentes. A prevalência influencia os valores preditivos na avaliação diagnóstica; aqui o foco passa a ser a relação entre exposição e desfecho.

O que entra nas linhas e nas colunas

1. **Defina o evento.** Pode ser infarto, câncer, sangramento, morte, cura ou controle da pressão.
2. **Defina os grupos.** Primeira linha: intervenção ou exposição em estudo. Segunda linha: comparação, como placebo, tratamento habitual ou ausência da exposição.
3. **Separe presença e ausência do evento.** A primeira coluna registra quem teve o desfecho; a segunda, quem não teve.
4. **Confira os totais.** Some cada linha. Se só houver o total e os eventos, obtenha os não eventos por subtração.

Grupo	Com desfecho	Sem desfecho	Total
Expostos / intervenção	A	B	A + B
Não expostos / controle	C	D	C + D

Na intervenção, o pesquisador oferece algo, como uma medicação. Na exposição observada, ele acompanha uma condição já presente, como fumar. Obesidade e diabetes são exemplos de fatores de risco que podem definir os grupos.

O grupo de comparação também pode receber tratamento: remédio novo e remédio padrão são duas intervenções diferentes. “Não exposto”, nesse caso, significa não exposto à intervenção principal em estudo.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Desfecho presente não significa resultado bom. “Infarto presente” é um evento desfavorável; “cura presente” é favorável. Nomeie o evento diretamente: ocorrência de infarto, em vez de “redução de infarto positiva ou negativa”.

Troque os nomes, mantenha a estrutura

Primeira linha	Segunda linha	Evento nas colunas
Tabagistas	Não tabagistas	Câncer de pulmão: sim / não.
Pessoas com obesidade	Pessoas sem obesidade	Hipertensão: sim / não.
Cirurgia	Tratamento clínico	Óbito: sim / não.

Exposição não determina o resultado de cada pessoa: um fumante pode não desenvolver câncer durante o acompanhamento, e uma pessoa que nunca fumou pode apresentar câncer por outros fatores.

O tempo de observação também importa: uma pessoa pode fumar e não desenvolver câncer nos cinco anos do acompanhamento, mesmo que venha a ter a doença depois.

Se o enunciado informa 200 tabagistas e 100 casos de câncer, os outros 100 são tabagistas sem o evento: 200 − 100 = 100.

Exemplo que acompanha a aula: medicação e infarto

O estudo acompanhou 200 pacientes, com 100 em cada grupo. Houve 10 infartos entre os que receberam a medicação e 20 entre os que receberam placebo.

Grupo	Infarto	Sem infarto	Total
Nova medicação	10	90	100
Placebo	20	80	100

Se o enunciado trouxer só os totais e os infartos, complete: 100 − 10 = 90 sem infarto na intervenção; 100 − 20 = 80 no placebo. O grupo controle mostra a frequência do evento na situação de comparação.

Quando o evento é favorável

Um programa de acompanhamento de hipertensos pode ter como evento o controle da pressão. Nesse caso, o objetivo é aumentar a ocorrência do desfecho.

Grupo	Pressão controlada	Não controlada	Total
Novo programa	70	30	100
Cuidado habitual	50	50	100

A montagem da tabela é a mesma. A diferença aparece na interpretação: mais controle da pressão representa benefício; mais infartos representa dano.

02 Risco absoluto: dentro de cada grupo

Para saber a probabilidade do evento em um grupo, divida o número de eventos pelo total de pessoas daquele grupo. Cada grupo tem seu próprio resultado.

O denominador é o total do próprio grupo PROVA

Risco absoluto = eventos ÷ participantes do grupo

Expostos: A ÷ (A + B). Controle: C ÷ (C + D).

NOVA MEDICAÇÃO

10 em 100

10 ÷ 100 = 0,10 = 10%

De cada cem participantes tratados, dez apresentaram infarto.

PLACEBO

20 em 100

20 ÷ 100 = 0,20 = 20%

De cada cem participantes do controle, vinte apresentaram infarto.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Não divida 10 pelos 200 participantes do estudo. O risco na medicação é 10 ÷ 100. O total de cada grupo pode ser diferente; por isso, compare proporções e confira o denominador antes de continuar.

Risco absoluto do grupo e redução absoluta do risco são conceitos diferentes. O primeiro descreve a ocorrência do evento em um grupo; a segunda, apresentada adiante, é uma diferença entre dois riscos.

Exemplo resolvido: náuseas

Uma medicação foi associada a náuseas em 18 de 100 pacientes. O risco absoluto de náusea nesse grupo foi 18 ÷ 100 = 0,18 = 18%.

03 Risco relativo: comparar e interpretar

Agora compare a probabilidade do mesmo evento nos dois grupos. O resultado diz quantas vezes o risco da intervenção corresponde ao risco do controle. Depois veja se aumentar esse evento ajuda ou prejudica.

Risco relativo = risco na intervenção ÷ risco no controle

No exemplo do infarto: 0,10 ÷ 0,20 = 0,5.

Resultado	O que acontece com o evento
Igual a 1	Os riscos observados nos dois grupos são iguais.
Menor que 1	O evento ocorre menos no grupo de intervenção.
Maior que 1	O evento ocorre mais no grupo de intervenção.

Um resultado de 0,5 significa metade do risco no grupo de comparação. Um resultado de 6 significa risco seis vezes o do grupo de comparação. O risco relativo é uma razão; a redução percentual será calculada em outra etapa.

Menor que 1 é sempre bom? PROVA

Desfecho	Risco relativo menor que 1	Risco relativo maior que 1
Desfavorável: infarto, morte ou sangramento.	Menos eventos desfavoráveis: direção de benefício.	Mais eventos desfavoráveis: direção de dano.
Favorável: cura, sobrevida ou controle da pressão.	Menos eventos favoráveis: direção desfavorável.	Mais eventos favoráveis: direção de benefício.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Leia o desfecho antes de chamar o resultado de protetor. Risco relativo de 0,5 para infarto significa menos infartos; o mesmo 0,5 para cura significa menor probabilidade de cura.

Tabagismo e câncer de pulmão

Entre 100 fumantes, 30 desenvolveram câncer de pulmão; entre 100 não fumantes, 5 desenvolveram a doença. Os demais foram 70 e 95, respectivamente.

Fumantes: 30 ÷ 100 = 30% · Não fumantes: 5 ÷ 100 = 5%
Risco relativo = 0,30 ÷ 0,05 = 6

O risco de câncer de pulmão nos fumantes foi seis vezes o dos não fumantes, no acompanhamento considerado.

Controle da pressão: aumento de um evento favorável

No novo programa, o risco absoluto do evento “pressão controlada” foi 70%; no habitual, 50%. Assim, 0,70 ÷ 0,50 = 1,4. A probabilidade de controlar a pressão foi 1,4 vez a do cuidado habitual.

O mesmo anticoagulante, dois resultados diferentes

Cálculo	Sangramento	Acidente vascular cerebral
Novo anticoagulante	24 ÷ 150 = 16%	10 ÷ 200 = 5%
Anticoagulante padrão	30 ÷ 300 = 10%	25 ÷ 200 = 12,5%
Risco relativo	0,16 ÷ 0,10 = 1,6	0,05 ÷ 0,125 = 0,4

Cálculo	Sangramento	Acidente vascular cerebral
Interpretação	O risco de sangramento foi 1,6 vez o do tratamento padrão.	O risco de acidente vascular cerebral foi 0,4 vez o do padrão.

Uma intervenção pode reduzir um evento e aumentar outro. O ácido acetilsalicílico, por exemplo, pode reduzir infarto e aumentar sangramento. É necessário olhar os desfechos relevantes em conjunto.

EXEMPLO RETOMADO PELO PROFESSOR

Na comparação comentada em aula sobre ramipril e vitamina C, foram avaliados morte, infarto e morte cardiovascular. O exemplo ilustra a necessidade de olhar vários resultados: o ramipril apresentou benefício nos desfechos citados, enquanto a vitamina C não mostrou diferença.

Sono e cefaleia

Se quem dorme menos de 6 horas apresenta cefaleia em 30% dos casos e quem dorme pelo menos 6 horas em 10%, o risco relativo é 0,30 ÷ 0,10 = 3: o risco no primeiro grupo é três vezes o do segundo.

04 Redução relativa e absoluta do risco

Desfecho e tabela · Risco do grupo · Comparação · **Redução** · Benefício e dano · Chances

A mesma mudança pode ser descrita pela proporção de redução em relação ao controle ou pela diferença de eventos no conjunto de pessoas. Por isso, cair de 20% para 10% tem duas leituras corretas.

Porcentagem de redução e pontos percentuais PROVA

Medida	Pergunta	De 20% para 10%
Redução relativa do risco	Que proporção do risco do controle foi reduzida?	Metade: 50% de redução relativa.
Redução absoluta do risco	Qual a diferença entre os riscos dos grupos?	10 pontos percentuais: dez eventos a menos por cem pessoas.

Redução relativa do risco = 1 − risco relativo
1 − 0,5 = 0,5 = 50%

Quando o risco relativo é menor que 1, basta identificar quanto falta para chegar a 1. Exemplos: 0,3 corresponde a redução de 70%; 0,95, de 5%; 0,99, de 1%; 0,2, de 80%.

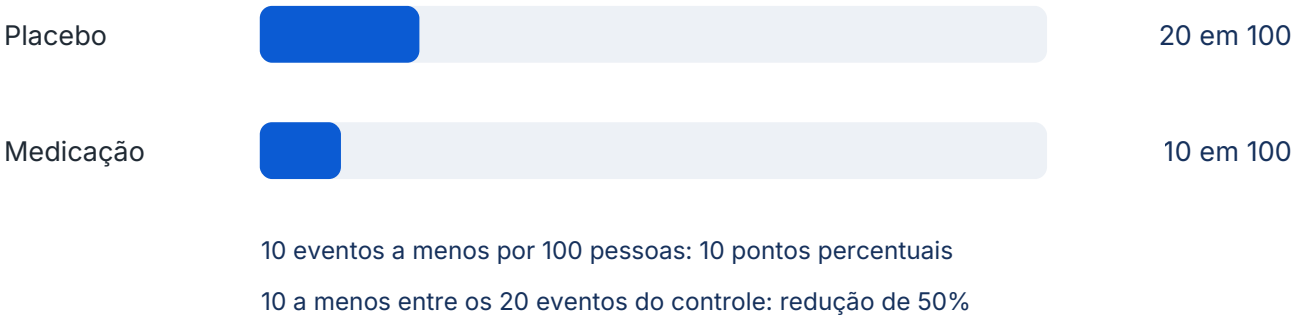
Redução absoluta do risco = risco no controle − risco na intervenção
0,20 − 0,10 = 0,10 = 10 pontos percentuais

Esta forma descreve benefício quando o evento desfavorável é menos frequente na intervenção.

Quando há aumento relativo

Para um evento desfavorável mais frequente na intervenção, o aumento relativo do risco é risco relativo − 1. O risco relativo de sangramento de 1,6 do anticoagulante representa aumento relativo de 60%.

O mesmo benefício, visto de duas formas



10 eventos a menos por 100 pessoas: 10 pontos percentuais

10 a menos entre os 20 eventos do controle: redução de 50%

As barras usam a mesma escala de cem pessoas. A diferença é de dez eventos por cem; em relação aos vinte eventos do controle, houve redução pela metade.

PEGADINHA DO PROFESSOR

"Maior risco menos menor risco" ajuda a lembrar a diferença quando há redução. Antes, confira a direção: se a intervenção aumenta um evento desfavorável, a diferença representa aumento absoluto do risco. Não transforme aumento de dano em redução benéfica.

Uma redução grande pode partir de um risco muito pequeno

Considere uma complicação que cai de 0,05% para 0,005%. A redução relativa é de 90%, mas a diferença absoluta é de apenas 0,045 ponto percentual. Para avaliar o tamanho do benefício, é preciso conhecer também o risco inicial.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

As comparações entre grupos descrevem frequências médias. Elas não permitem identificar quais pessoas específicas teriam o evento com ou sem tratamento.

Exemplo resolvido: prevenção de acidente vascular cerebral

Entre 200 pacientes que receberam a medicação, 20 tiveram acidente vascular cerebral; entre 200 que receberam placebo, 40 tiveram o evento.

Etapa	Conta
Risco na medicação	20 ÷ 200 = 0,10 = 10%
Risco no placebo	40 ÷ 200 = 0,20 = 20%
Risco relativo	0,10 ÷ 0,20 = 0,5
Redução relativa	1 − 0,5 = 0,5 = 50%
Redução absoluta	0,20 − 0,10 = 0,10 = 10 pontos percentuais

Outras duas comparações da aula

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Internação: 25% para 10%

Nova medicação: 10 em 100. Placebo: 25 em 100.

Risco relativo: 0,10 ÷ 0,25 = 0,4.
Redução relativa: 60%.
Redução absoluta: 15 pontos percentuais.

EVENTO DESFAVORÁVEL

Risco: 8% para 4%

Controle: 8%. Intervenção: 4%.

Risco relativo: 0,04 ÷ 0,08 = 0,5.
Redução relativa: 50%.
Redução absoluta: 4 pontos percentuais.

05 Quantos tratar? Benefício e dano

Desfecho e tabela | Risco do grupo | Comparação | Redução | **Benefício e dano** | Chances

Nem toda pessoa tratada terá um evento evitado. A diferença de risco entre grupos permite estimar quantas pessoas precisam receber a intervenção para evitar um evento adicional, em comparação ao controle.

Da diferença de risco ao número de pessoas

Número necessário para tratar = 1 ÷ redução absoluta do risco

Use a redução na forma decimal: 10 pontos percentuais correspondem a 0,10.

No exemplo do infarto, 1 ÷ 0,10 = 10. Isso significa tratar dez pacientes para evitar um infarto adicional em relação ao grupo de comparação. Quanto menor esse número, maior o benefício absoluto, para o mesmo desfecho e contexto.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Não use "10" como denominador para uma redução de 10 pontos percentuais. A conta é 1 ÷ 0,10. Também não use a redução relativa de 50%: o cálculo depende da diferença absoluta entre os grupos.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O número necessário para tratar se refere ao período de acompanhamento do estudo. Ele não significa que, em cada grupo concreto de dez pessoas, será possível apontar exatamente uma que teve o evento evitado.

Mobilização precoce: arredonde para cima PROVA

Após cirurgia abdominal, 20 dos 250 pacientes do protocolo de mobilização precoce desenvolveram pneumonia hospitalar. No cuidado habitual, foram 64 de 400.

Etapa	Conta
Risco na mobilização	20 ÷ 250 = 0,08 = 8%
Risco no cuidado habitual	64 ÷ 400 = 0,16 = 16%
Risco relativo	0,08 ÷ 0,16 = 0,5

Etapa	Conta
Redução relativa	1 − 0,5 = 0,5 = 50%
Redução absoluta	0,16 − 0,08 = 0,08 = 8 pontos percentuais
Número necessário para tratar	1 ÷ 0,08 = 12,5; arredondando para cima: 13 pacientes.

É necessário submeter 13 pacientes ao protocolo para evitar uma pneumonia adicional em comparação ao cuidado habitual. Não existe meio paciente na aplicação desse resultado.

Outra conta: de 12% para 8%

Se o risco no controle é 12% e na intervenção é 8%, a redução absoluta é 4 pontos percentuais, ou 0,04. Logo, 1 ÷ 0,04 = 25 pacientes para evitar um evento adicional.

O contraponto: número necessário para causar dano

O número necessário para causar dano estima quantos pacientes precisam receber a intervenção para que ocorra um evento adverso adicional. A interpretação da intervenção depende tanto do benefício quanto do dano.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Quando há aumento de um evento adverso: **número necessário para causar dano = 1 ÷ aumento absoluto do risco**. O aumento absoluto é o risco na intervenção menos o risco no controle, em decimal.

Aspirina: a população muda o equilíbrio

Contexto do exemplo	Para evitar um infarto	Para causar um sangramento
Prevenção secundária: quem já teve infarto ou acidente vascular cerebral.	77 pacientes tratados.	400 pacientes tratados.
Prevenção primária: quem nunca teve esses eventos.	333 pacientes tratados.	250 pacientes tratados.

No primeiro cenário, o benefício é mais frequente que o sangramento adicional; no segundo, o sangramento adicional é mais frequente que o infarto evitado. O exemplo mostra por que o mesmo remédio pode ter utilidade diferente em populações distintas.

> “Uma decisão clínica depende do equilíbrio do benefício e do dano, como quase tudo na medicina.”
>
> DR. FILIPE ALMEIDA

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Esses valores ilustram os cenários discutidos e não são constantes universais da aspirina. A decisão também depende da gravidade dos eventos, do risco individual, do tempo de seguimento e das contraindicações. Comparar apenas os números não substitui essa avaliação.

PARÊNTESE DO PROFESSOR · TAMANHO DO BENEFÍCIO

O valor 1 foi apresentado como ideal não encontrado na prática: um evento evitado por pessoa tratada. A aula citou valores de 1,2 e 1,5 como exemplos de benefícios muito grandes de antibióticos hospitalares, para ilustrar que valores menores representam maior efeito absoluto.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O valor 1 é matematicamente possível se a diferença absoluta for 100 pontos percentuais. Não existe um número necessário para tratar único para "antibióticos hospitalares": cada estimativa exige uma intervenção, uma população, um desfecho e um período definidos.

Recurso indicado na aula: The NNT · thennt.com, com sínteses de benefícios e danos de intervenções.

06 Odds e razão de chances

Desfecho e tabela | Risco do grupo | Comparação | Redução | Benefício e dano | **Chances**

No estudo de caso-controle, a seleção começa por quem tem e quem não tem a doença, e depois se examina a exposição anterior. Como esses grupos são escolhidos pelo desfecho, a amostra não fornece diretamente o risco de adoecer.

Probabilidade e odds não são a mesma conta

O risco usa eventos divididos pelo total do grupo. A odds, traduzida como chance em seu sentido técnico, usa eventos divididos por não eventos. A razão de chances compara duas odds.

Medida	Expostos	Não expostos
Risco absoluto	A ÷ (A + B)	C ÷ (C + D)
Odds	A ÷ B	C ÷ D

Razão de chances: multiplicação cruzada PROVA

Multiplicação cruzada: o "peixinho"

	Com evento	Sem evento
Expostos	A	B
Não expostos	C	D

$$\frac{A \times D}{B \times C}$$

Mantenha a mesma ordem das linhas e colunas em toda a conta.

Razão de chances = (A ÷ B) ÷ (C ÷ D)
Razão de chances = (A × D) ÷ (B × C)

Tabagismo e câncer de pulmão

Grupo	Com câncer	Sem câncer
Fumantes	A = 80	B = 40
Não fumantes	C = 20	D = 60

Odds nos fumantes: 80 ÷ 40 = 2. Nos não fumantes: 20 ÷ 60 = 1/3. A razão é 2 ÷ (1/3) = 6.

(80 × 60) ÷ (40 × 20) = 4.800 ÷ 800 = 6

A odds de câncer entre fumantes é seis vezes a odds entre não fumantes. Não troque essa frase por "a probabilidade é seis vezes maior": odds e probabilidade têm denominadores diferentes.

PEGADINHA DO PROFESSOR

Não calcule risco diretamente de uma amostra típica de caso-controle. Para a razão de chances, use a multiplicação cruzada. Evite arredondar resultados intermediários: mantenha 20/60 como fração e arredonde só o resultado final.

Uso de telas antes de dormir e insônia

Das 60 pessoas que usavam telas, 30 tinham insônia. Das 40 que não usavam, 10 tinham insônia. Complete os não eventos: 60 − 30 = 30; 40 − 10 = 30.

Grupo	Com insônia	Sem insônia
Usam telas	30	30
Não usam telas	10	30

(30 × 30) ÷ (30 × 10) = 900 ÷ 300 = 3

A odds de insônia foi três vezes a do grupo que não usava telas.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O enunciado de telas permite calcular a razão de chances, mas não informa como os participantes foram selecionados. Pessoas já apresentarem a doença não basta para definir caso-controle; o exemplo também pode representar uma avaliação transversal. A razão de chances pode ser calculada em outros desenhos.

Energéticos e palpitação

Grupo	Com palpitação	Sem palpitação
Consumo frequente	A = 9	B = 141
Grupo de comparação	C = 6	D = 294

(9 × 294) ÷ (141 × 6) = 2.646 ÷ 846 ≈ 3,13

A odds de palpitação foi aproximadamente 3,13 vezes a do grupo de comparação. O valor é arredondado para duas casas decimais apenas no fim.

07 O essencial da aula

Página de véspera: tabela, riscos de cada grupo, comparação e interpretação do evento.

PROVA **1 · Tabela.** Linhas: exposição ou intervenção. Colunas: evento presente ou ausente. A/B: expostos. C/D: controles. Desfecho presente pode ser bom ou ruim.

2 · Risco absoluto = eventos ÷ total do próprio grupo
Intervenção: A ÷ (A + B) · Controle: C ÷ (C + D)

PROVA **3 · Risco relativo.** Intervenção ÷ controle. Igual a 1: riscos iguais; menor que 1: menos eventos; maior que 1: mais eventos. Benefício ou dano depende do desfecho.

4 · Redução relativa = 1 − risco relativo
Redução absoluta = risco no controle − risco na intervenção
Para redução de evento desfavorável. De 20% para 10%: 50% de redução relativa e 10 pontos percentuais de redução absoluta.

PROVA **5 · Número necessário para tratar.** 1 ÷ redução absoluta em decimal. Com 0,10: 10 pessoas. Na mobilização: 1 ÷ 0,08 = 12,5; arredonde para 13. De 12% para 8%: 25 pessoas.

Atenção Benefício e dano precisam ser avaliados juntos. Aspirina no exemplo: prevenção secundária, 77 para evitar infarto e 400 para causar sangramento; primária, 333 e 250.

PROVA **6 · Razão de chances.** (A × D) ÷ (B × C). Caso-controle não fornece risco diretamente. Tabagismo: 6; telas: 3; energéticos: aproximadamente 3,13.

TRÊS ERROS PARA EVITAR

Usar o total do estudo no risco de um grupo; confundir porcentagem com pontos percentuais; interpretar razão de chances como se fosse risco relativo.

Palavras da aula em linguagem simples

Coorte	Estudo que acompanha grupos ao longo do tempo e observa a ocorrência de eventos.
Ensaio clínico	Estudo em que se aplica uma intervenção e se comparam seus resultados aos de um grupo controle.
Placebo	Comparador sem o componente ativo da intervenção em estudo.

Prevenção primária	No exemplo cardiovascular, prevenção em quem ainda não teve infarto ou acidente vascular cerebral.
Prevenção secundária	No exemplo cardiovascular, prevenção de novos eventos em quem já teve infarto ou acidente vascular cerebral.

ANOTAÇÕES